TÓM TẮT ĐẠT MỨC 5 – TIÊU CHÍ C6.3
“Người bệnh được chăm sóc bảo đảm toàn diện”

Để đạt **mức 5**, bệnh viện phải chứng minh được:
✅ Người bệnh được chăm sóc toàn diện, liên tục, cá thể hóa
✅ Điều dưỡng thực hiện đầy đủ chức năng chăm sóc
✅ Có phối hợp đa chuyên khoa
✅ Có giám sát – đánh giá – cải tiến liên tục
✅ Người bệnh hài lòng và tham gia chăm sóc

1. HỆ THỐNG CHĂM SÓC TOÀN DIỆN ĐẦY ĐỦ
Bắt buộc phải có:
✅ Quy định chăm sóc toàn diện
✅ SOP chăm sóc NB
✅ Phân cấp chăm sóc
✅ Quy trình bàn giao NB
✅ Quy trình theo dõi NB nguy cơ cao
Có:
- Kế hoạch chăm sóc
- Phiếu chăm sóc
- Checklist chăm sóc

2. ĐIỀU DƯỠNG THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CHĂM SÓC
Người bệnh phải được:
Chăm sóc thể chất
- vệ sinh cá nhân
- dinh dưỡng
- vận động
- theo dõi dấu hiệu sinh tồn
- phòng loét tỳ đè
- phòng té ngã

Chăm sóc tinh thần
- giao tiếp
- hỗ trợ tâm lý
- giải thích điều trị

Chăm sóc phục hồi
- hướng dẫn vận động
- tự chăm sóc
- giáo dục sức khỏe

3. CÓ PHÂN CẤP CHĂM SÓC RÕ RÀNG
Mức 5 yêu cầu:
NB được phân loại:
✅ chăm sóc cấp I
✅ cấp II

✅ cấp III
✅ chăm sóc đặc biệt

Hồ sơ phải có:

- đánh giá ban đầu
- lượng giá lại
- thay đổi mức chăm sóc

4. KẾ HOẠCH CHĂM SÓC CÁ THỂ HÓA

Không được ghi chung chung

Phải:

✅ phù hợp bệnh lý
✅ có mục tiêu chăm sóc
✅ có lượng giá kết quả
✅ cập nhật theo diễn biến

Ví dụ:

NB	Chăm sóc ưu tiên
Sau mổ	Giảm đau – vận động sớm
Tai biến	Phòng loét – phục hồi
COPD	Tập thở
Đái tháo đường	Theo dõi đường huyết

5. PHỐI HỢP ĐA CHUYÊN KHOA

Muốn mức 5:

Điều dưỡng phải phối hợp:

✅ bác sĩ
✅ dinh dưỡng
✅ PHCN
✅ kiểm soát nhiễm khuẩn
✅ CTXH
✅ dược lâm sàng

6. GIÁM SÁT – AUDIT – KPI

Phải có audit ≥12 tháng:

- hồ sơ chăm sóc
- bàn giao
- tuân thủ chăm sóc nguy cơ cao

KPI ví dụ:

Chỉ số	Mục tiêu
Hồ sơ chăm sóc đạt	≥95%
Loét tỳ đè bệnh viện	giảm liên tục
Té ngã NB	giảm liên tục
NB hài lòng chăm sóc	≥90%

7. QUẢN LÝ NGUY CƠ NGƯỜI BỆNH

Đây là phần rất quan trọng mức 5

Phải có:

✅ đánh giá nguy cơ té ngã
✅ nguy cơ loét tỳ đè
✅ nguy cơ suy dinh dưỡng
✅ nguy cơ tự tử/bạo lực (nếu có)

Có:

- thang điểm chuẩn
- theo dõi liên tục
- can thiệp phù hợp

8. HỒ SƠ CHĂM SÓC PHẢI ĐẦY ĐỦ

Đoàn thường kiểm:

✅ đánh giá ban đầu
✅ kế hoạch chăm sóc
✅ lượng giá
✅ ký tên đúng
✅ theo dõi liên tục

Không được:

❌ ghi đối phó
❌ sao chép giống nhau
❌ bỏ trống lượng giá

9. NGƯỜI BỆNH HÀI LÒNG THỰC SỰ

Đoàn thường hỏi NB:

- Có được hỗ trợ vệ sinh không?
- Có được hướng dẫn ăn uống không?
- Điều dưỡng có theo dõi thường xuyên không?
- Có phản hồi nhanh khi cần không?

Muốn mức 5:

NB phải phản hồi tích cực thực tế.

10. ỨNG DỤNG CNTT (ĐIỂM CỘNG MẠNH)

Nên có:

- Hồ sơ chăm sóc điện tử
- Dashboard nguy cơ NB
- Cảnh báo té ngã điện tử
- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn tự động
- Kế hoạch chăm sóc điện tử

11. CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Cần có:

✅ phân tích sự cố chăm sóc
✅ cải tiến quy trình
✅ giảm loét/té ngã
✅ theo dõi hiệu quả cải tiến

Ví dụ:

Vấn đề	Cải tiến
Loét tăng	Đệm chống loét

Vấn đề	Cải tiến
Té ngã	Vòng cảnh báo nguy cơ
Hồ sơ thiếu	Audit hàng tuần

12. MINH CHỨNG "ĂN ĐIỂM" MỨC 5

✅ Kế hoạch chăm sóc cá thể hóa
✅ Audit định kỳ
✅ Dashboard chăm sóc
✅ Hồ sơ điện tử
✅ Theo dõi nguy cơ chuẩn hóa
✅ NB hài lòng cao
✅ Có cải tiến liên tục
✅ Điều dưỡng chăm sóc thực chất tại giường

13. NHỮNG LỖI CHỈ ĐẠT MỨC 3–4

❌ Chăm sóc hình thức
❌ Không lượng giá NB
❌ Không phân cấp chăm sóc
❌ Hồ sơ ghi đối phó
❌ Không quản lý nguy cơ
❌ Không audit liên tục
❌ Không cải tiến sau sự cố

14. CÔNG THỨC NGẮN GỌN ĐẠT MỨC 5 C6.3

Mức 5 =
Chăm sóc toàn diện thực chất

- **Kế hoạch chăm sóc cá thể hóa**
- **Quản lý nguy cơ tốt**
- **Audit – KPI liên tục**
- **NB hài lòng**
- **Ứng dụng CNTT**
- **Cải tiến chất lượng**

= ĐẠT MỨC 5 C6.3.